



ANNALES OFFICIELLES EVC

EVCF 2012

Épreuve de vérification des connaissances fondamentales

Médecine générale (code 71)

SUJETS

6

QUESTIONS

21

SUJET

01

Cas clinique · 4 questions

VIGNETTE CLINIQUE

: HEMATOLOGIE Une femme de 34 ans se présente en consultation avec l'hémogramme suivant : Gr : 3,9 millions/m³ Hémoglobine : 8 g/dl VGM : 68 fl Hte : 27 % Plaquettes : 510000/m³ GB : 6 300 /m³ PN : 62% PE : 2 % PB : 0 Lymphocytes : 28 % Monocytes : 8 %

1

QUESTION 1

Décrivez les anomalies de l'hémogramme.

2

QUESTION 2

Concernant la lignée érythrocytaire, citez les 2 mécanismes physiopathologiques principaux envisageables.

3

QUESTION 3

Quel est l'examen biologique courant le plus adapté pour faire un premier tri entre ces mécanismes ? (Une seule réponse)

4

QUESTION 4

Quel est le résultat attendu de cet examen pour chacun des 2 mécanismes ? Tournez S.V.P. (

SUJET

02

Cas clinique · 4 questions

VIGNETTE CLINIQUE

: CARDIO-VASCULAIRE Vous êtes appelé au domicile de M. G., 65 ans, 1m78, 95 kg, hypertendu traité, tabagique chronique, pour une violente douleur de la jambe gauche survenue 4 heures auparavant et persistant depuis. A votre arrivée vous notez une jambe gauche blanche et froide.

1

QUESTION 1

Quelle est votre principale hypothèse diagnostique ? (Sans détailler)

2

QUESTION 2

Tenant compte de votre hypothèse, quels sont les 3 signes cliniques que vous devez rechercher à ce stade sur ce membre inférieur gauche ?

3

QUESTION 3

Ces 3 signes vont vous apporter des renseignements importants pour votre prise en charge thérapeutique. Quels sont ces 3 renseignements ?

4

QUESTION 4

Quels sont les 2 grands mécanismes physiopathologiques que vous devez évoquer de principe pour expliquer la symptomatologie aiguë présentée par M.G. (sans détailler) Tournez S.V.P. (

SUJET

03

Cas clinique · 3 questions

VIGNETTE CLINIQUE

: POLYPATHOLOGIE DU SUJET AGE Patiente de 85 ans adressée aux urgences après une chute (retrouvée sur le sol par sa voisine) et confuse. ATCD : HTA Diabète de type II Ostéoporose AC/FA Conditions de vie : veuve depuis 3 mois, vit seule, autonome auparavant. Traitement : Warfarine (Coumadine) Bêta bloquant : cardensiel 2,5 - 1 cp /jour Diamicron 60 LM 1 cp - 1 cp le matin Amlor (Amlodipine) 5 1 cp - 1/jour Contramal LP (Tramadol) 2 cp x jour Lexomil ½ cp le soir depuis quelques jours Bilan biologique : Glycémie 0,70 g/l Na : 147 mMol/l K : 4 mMol/l Créatinine : 120 µmol/l Urée : 15 mMol/l INR : 2,10

1

QUESTION 1

Citez 5 mécanismes favorisant ou précipitant la chute chez cette patiente.

2

QUESTION 2

Citez les 5 caractéristiques principales du syndrome confusionnel.

3

QUESTION 3

Citez 5 causes possibles de l'insuffisance rénale chez cette patiente ? Tournez S.V.P. (

SUJET

04

Cas clinique · 3 questions

VIGNETTE CLINIQUE

: RHUMATOLOGIE Une patiente âgée de 55 ans consulte pour des lombalgies évoluant depuis 9 semaines. Il existe un syndrome rachidien à l'examen clinique.

1

QUESTION 1

Citez les 5 principaux diagnostics que vous devez évoquer.

2

QUESTION 2

Citez les 3 signes cliniques qui imposent une prise en charge en urgence.

3

QUESTION 3

En dehors de l'urgence, citez les 4 examens paracliniques contribuant au diagnostic étiologique.

SUJET

05

Cas clinique · 4 questions

VIGNETTE CLINIQUE

: INFECTIOLOGIE Vous accueillez un patient âgé de 42 ans, se plaignant d'une toux traînante dans un contexte d'asthénie et d'amaigrissement. Il est fébrile depuis 3 semaines environ. Ce patient originaire d'Ukraine vit en France depuis 3 ans avec sa famille dans des conditions précaires. Sa radiographie du thorax retrouve un infiltrat du lobe supérieur gauche.

1

QUESTION 1

Quel est le diagnostic le plus probable (1 seul diagnostic).

2

QUESTION 2

Quelles mesures immédiates mettez-vous en œuvre dans la prise en charge de ce patient ?

3

QUESTION 3

Quelles sont les techniques microbiologiques permettant d'établir le diagnostic ?

4

QUESTION 4

Quelle maladie associée devez-vous rechercher et quel examen supplémentaire demandez-vous (1 seul) ? Tournez S.V.P. (

SUJET

06

Cas clinique · 3 questions

VIGNETTE CLINIQUE

: DIGESTIF Un homme de 50 ans, travaillant dans le bâtiment, se présente avec des douleurs abdominales aiguës épigastriques transfixiantes. Il est amené aux urgences par le SMUR. L'inspection montre un patient allongé, pâle, parlant difficilement. Le patient est fumeur chronique (25 paquets/année) et déclare avoir majoré récemment sa consommation d'alcool en raison de soucis familiaux et professionnels. Il n'a pas d'antécédent particulier en dehors de céphalées assez fréquentes.

1

QUESTION 1

Quelles sont les 4 principales causes de la douleur que vous devez évoquer en urgence chez ce patient ?

2

QUESTION 2

Enumérer les signes habituels d'un état de choc.

3

QUESTION 3

Enumérer les signes habituels d'une irritation péritonéale. B.DOC